

CURSO DE APROFUNDAMENTO EM SELETIVIDADE ALIMENTAR INFANTIL

Módulo 1

Entendendo a Seletividade Alimentar

Desenvolvimento alimentar típico • Neofobia, seletividade e TARE • Epidemiologia
Impactos nutricionais • Sinais de alerta

Material técnico para profissionais de nutrição

O que vamos construir

01 Desenvolvimento alimentar típico

Da sucção reflexa à autorregulação — o mapa do que é esperado

02 Neofobia × Seletividade × TARE

Três construtos, três condutas diferentes

03 Epidemiologia

Prevalência na população geral e em grupos de risco

04 Impactos nutricionais

O que a seletividade custa ao corpo — nem sempre visível na balança

05 Sinais de alerta

Quando encaminhar para avaliação multidisciplinar

FECHAMENTO

2 casos clínicos

Aplicando cada conceito a situações reais de consultório — condicionamento aversivo e sistema de recompensa.

“Toda rejeição é um erro em algum nível da cascata — não birra.”

MOTOR-ORAL

Habilidades orais e motoras que sustentam funções essenciais como alimentação, fala e expressão.



Mastigação



Sucção



Fala



Controle labial



Controle lingual

SENSORIAL

Processamento e integração das informações sensoriais do corpo e do ambiente.



Toque



Textura



Som



Equilíbrio



Paladar

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

COMPORTAMENTAL

Capacidades comportamentais e emocionais que promovem autonomia, interação e aprendizado.



Autonomia



Interação social



Autorregulação



Aprendizado



INTERCONECTADOS

O desenvolvimento motor-oral, sensorial e comportamental não acontece isoladamente. Eles se influenciam e se fortalecem mutuamente em cada conquista.



DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

Quando há equilíbrio entre os pilares, a criança se desenvolve de forma plena, segura e confiante para explorar o mundo e se tornar quem ela é.

MARCOS DO DESENVOLVIMENTO ALIMENTAR

A alimentação se desenvolve através da integração entre habilidades **motor-oraís**, processamento **sensoriais** e **comportamentais** aprendidos.

	 MARCOS MOTOR-ORAIS Habilidades e funções orais necessárias para comer	 MARCOS SENSORIAIS Como a criança processa e responde às experiências alimentares	 MARCOS COMPORTAMENTAIS Atitudes, interesses e comportamentos relacionados à alimentação
 0-6 MESES	 • Reflexo de busca e sucção • Coordenação sucção–deglutição–respiração • Língua em movimento de peristaltismo • Deglutição predominantemente líquida	 • Sensibilidade a sabores básicos • Preferência por sabores adocicados • Conforto com o sabor do leite materno • Respostas corporais a temperaturas	 • Reconhece o alimento (leite materno) • Busca ativa pelo alimento • Regula fome e saciedade • Vínculo e prazer na amamentação
 6-9 MESES	 • Reflexo de protrusão da língua diminui • Início do movimento de mastigação vertical • Controle de lábios para retirada do alimento • Deglutição de alimentos pastosos	 • Início da exploração sensorial dos alimentos • Tolerância a novas cores e cheiros • Aceita diferentes temperaturas • Totalmente sensorial oral (leva tudo à boca)	 • Interesse pelo alimento do outro • Aceita ser alimentado • Início da curiosidade • Respostas emocionais às refeições
 9-12 MESES	 • Mastigação vertical mais eficiente • Início da mastigação lateral • Manipula alimentos com gengiva • Transição para texturas com pedacinhos	 • Diferencia e prefere texturas • Mais seletividade natural (sabor/cheiro) • Reage a combinações de sabores • Início das preferências alimentares	 • Participa das refeições • Inicia alimentação com as mãos • Expressa preferências e recusas • Observa e imita o adulto
 12-18 MESES	 • Mastigação lateral estabelecida • Movimentos de trituração mais maduros • Controle de língua para manipular o alimento • Início da fala relacionada à alimentação	 • Processa melhor misturas de sabores • Aumenta tolerância a texturas variadas • Pode apresentar fase de neofobia inicial • Integra experiências positivas/negativas	 • Busca autonomia para comer • Recusas mais frequentes (normal) • Demonstra preferências claras • Início de rituais e rotinas
 18-24 MESES	 • Mastigação madura para a maioria dos alimentos • Morde, tritura e move o alimento lateralmente • Coordenação mordida + mastigação • Consegue comer alimentos da família	 • Neofobia mais evidente (18–24 meses) • Reage a texturas mais complexas • Consolidação de preferências • Lembra experiências anteriores	 • Mais autonomia e escolhas • Maior resistência ao novo • Testa limites e negocia • Repete o que traz segurança
 2-3 ANOS	 • Mastigação eficiente e coordenada • Controle total de língua e lábios • Deglutição madura para sólidos • Fala mais clara sobre alimentos	 • Neofobia fisiológica (pico 2–3 anos) • Prefere alimentos conhecidos • Sensibilidade a texturas específicas • Amplia repertório lentamente	 • Forte preferência por rotina • Recusas frequentes ao desconhecido • Influência do ambiente e pares • Construção da identidade alimentar



O desenvolvimento alimentar é único e não linear. Esses marcos são referências para compreender o processo e identificar sinais de alerta.



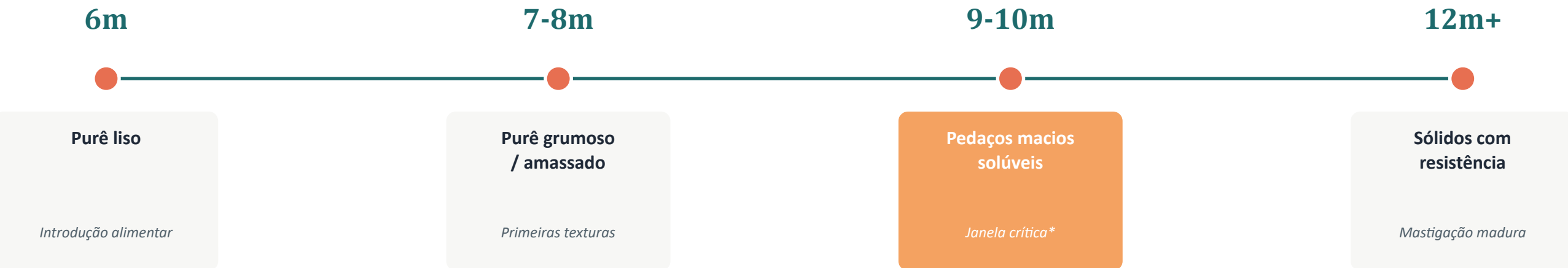
FATO IMPORTANTE:

A integração entre motor, sensorial e comportamento é o que permite que a criança evolua na alimentação.



Uma habilidade aprendida, não instintiva

A alimentação integra maturação motor-oral, sensorial e comportamental — não emerge pronta.



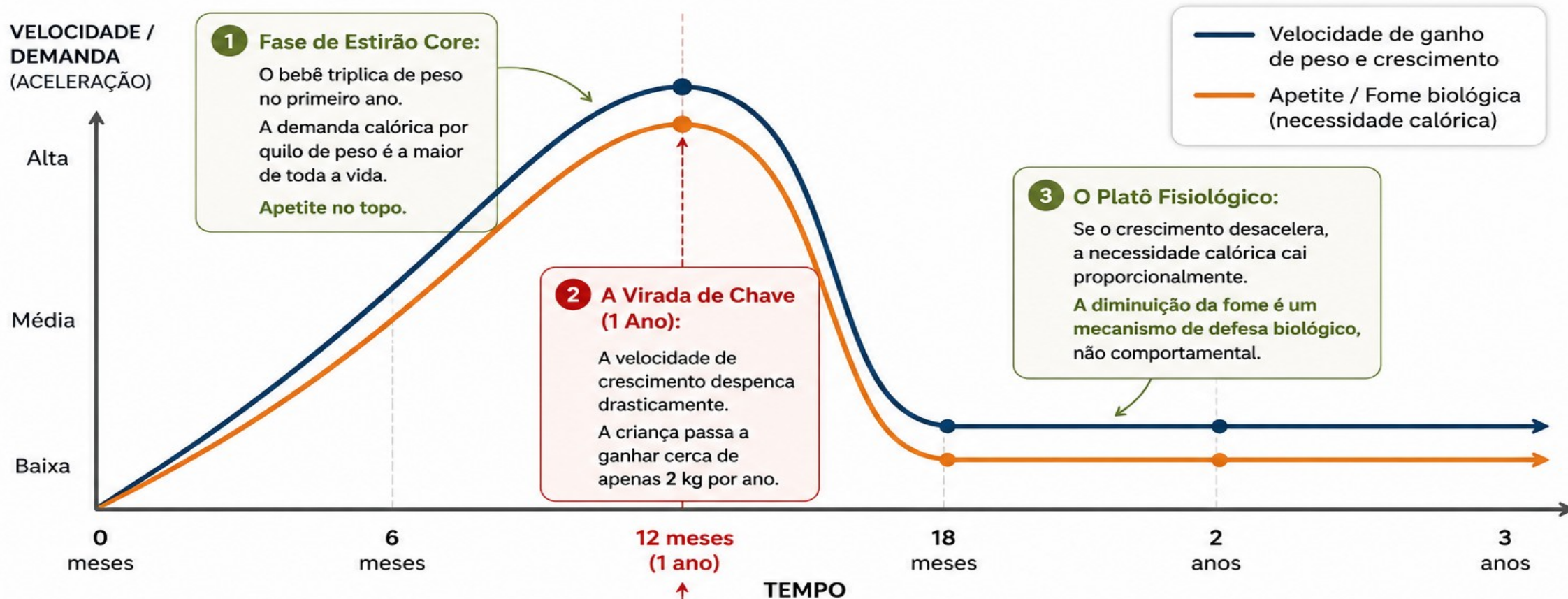
* Northstone et al. (2001) — grumos após 9-10 meses associam-se a mais dificuldades alimentares aos 15 meses e menor variedade alimentar aos 7 anos.

Modelo de Divisão de Responsabilidade (Ellyn Satter)

Adulto decide: o quê, quando, onde. **Criança decide:** se come e quanto come.

Por que a comida do prato diminuiu?

A matemática por trás dos 2 anos.



0 a 12 meses:

Crescimento acelerado = Alta demanda energética (prioridade biológica: crescer)



A partir de 12 meses:

Crescimento desacelera = Menor demanda energética (prioridade biológica: explorar, aprender, brincar)



Mensagem-chave: O corpo da criança é inteligente. Ele ajusta o apetite à sua necessidade real de crescimento. Respeitar essa queda é proteger o desenvolvimento e a relação saudável com a comida.

A curva da exposição repetida

8–15

exposições em média até a aceitação de um
alimento novo

Fildes & Cooke

Sem coerção: pressão reduz autorregulação e
pode reforçar rejeição (Galloway et al., 2006).

Visual

Ver o alimento
repetidamente na
mesa/prato

Olfativa / tátil

Cheirar, tocar, manipular
— sem exigência de
ingestão

Gustativa

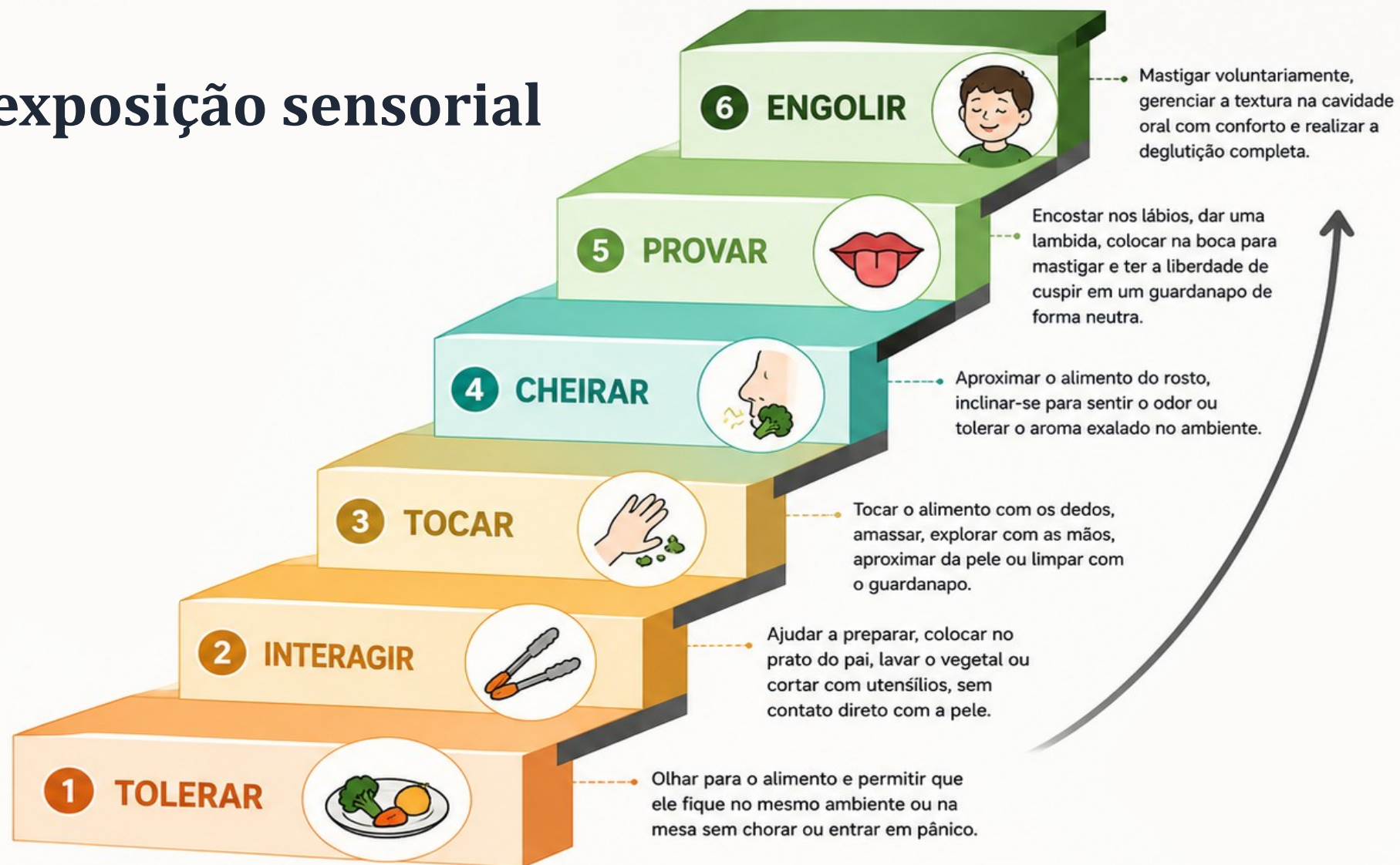
Lamber, provar em
pequena quantidade

Nem toda exposição exige ingestão — a exposição não-ingestiva já reduz neofobia.

Programas de referência

Food Dudes e **Tiny Tastes** (Lowe & Horne) — programas estruturados de exposição repetida sem coerção, com evidência de aumento sustentado de aceitação de vegetais e frutas em pré-escolares.

Hierarquia da exposição sensorial



Segurança
sempre



Respeito ao
tempo da criança



Neurociência a
nosso favor



Ambiente
positivo



Pequenas conquistas,
grandes avanços

NEOFOBIA, SELETIVIDADE E TARE

Entender as diferenças para transformar a conduta



NEOFOBIA ALIMENTAR

Fase do desenvolvimento típico

- Rejeição apenas ao que é **NOVO**.
- Fase normativa e evolutiva (pico aos 2-3 anos).
- Cede facilmente com exposição repetida e neutra (10 a 15 vezes).



SELETIVIDADE ALIMENTAR

Transtorno alimentar comportamental

- Rejeição a alimentos novos E familiares.
- Comportamento rígido que impacta a rotina diária.
- Geralmente aceita menos de **20** alimentos, mas sem desnutrição severa.



- Perturbação alimentar com falha persistente em suprir demandas nutricionais.
- Esquiva por medo de consequências aversivas (engasgo/vômito) ou apatia total pelo comer.
- Marcado impacto clínico: perda de peso significativa, deficiência nutricional grave ou dependência de suplementos/sondas.

Três construtos, três condutas

	Neofobia	Seletividade	TARE / ARFID
Natureza	Fenômeno desenvolvimental, adaptativo	Padrão comportamental amplo	Condição clínica (DSM-5)
Pico etário	2–6 anos	Toda 1ª infância	Qualquer idade
Curso	Resolução espontânea	Majoritariamente autolimitado	Não resolve sem intervenção
Impacto	Nenhum	Geralmente nenhum	Nutricional / ponderal / psicossocial

Nem toda criança seletiva tem TARE — a diferença está no impacto funcional, não na quantidade de alimentos aceitos.

Os três perfis do TARE

Zickgraf & Bryant-Waugh — perfis não mutuamente exclusivos; frequentemente coexistem.

1

Sensorial

Hipersensibilidade tátil, gustativa ou olfativa intraoral. Forte associação com TEA e transtorno de processamento sensorial.

2

Baixo interesse / appetite

Disfunção de sinalização fome-saciedade. Comum comorbidade com TDAH e desatenção.

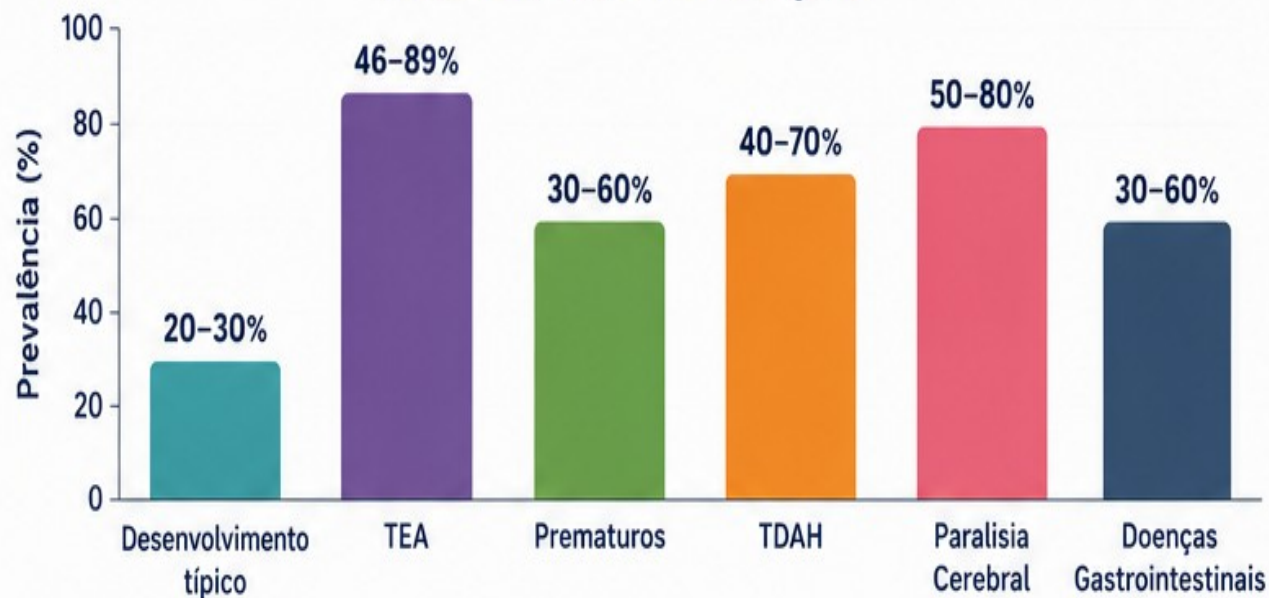
3

Medo de consequências aversivas

Origem pós-traumática: engasgo, vômito, procedimento invasivo, alergia com anafilaxia prévia.

Quanto isso realmente afeta as crianças

**PREVALÊNCIA DE SELETIVIDADE ALIMENTAR
EM DIFERENTES POPULAÇÕES**



Faixas amplas na literatura — refletem heterogeneidade de instrumentos e definições usadas nos estudos.

2-6 anos

faixa etária de maior concentração de casos de seletividade
(Taylor et al., 2015)

2013

O TARE foi formalizado como diagnóstico no DSM-5 — por isso a base de dados de prevalência ainda é mais recente e restrita que a de seletividade em geral.

Seletividade alimentar em crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista

Food selectivity in children and adolescents with autism spectrum disorder

Lilia Schug de Moraes¹, Vanessa Kern Bubolz², Anne y Castro Marques³ Lucia Rota Borges⁴, Ludmila Correa Muniz⁵, Renata Torres Abib Bertacco⁶

Estudo transversal realizado em Pelotas (RS) com 73 crianças e adolescentes com TEA encontrou prevalência de seletividade alimentar em 53,4% da amostra, caracterizada principalmente por fatores sensoriais — odor (56,4%), textura (53,9%), aparência (53,8%) e temperatura (51,3%) dos alimentos. O subtipo "sensorial" do TARE.

Seletividade alimentar infantil: Uma revisão integrativa

Children's food selectivity: An integrative review

Selectividad alimentaria infantil: Una revisión integrativa

Recebido: 09/11/2023 | Revisado: 17/11/2023 | Aceitado: 18/11/2023 | Publicado: 21/11/2023

Uma revisão integrativa brasileira (usando bases SciELO e BVS) aponta que a seletividade alimentar infantil é comum entre 2 e 6 anos e pode comprometer a ingestão de nutrientes essenciais, com estudos de Machado et al. (2017) demonstrando que de 20 a 60% das crianças avaliadas apresentavam algum grau de seletividade.

A mesma revisão destaca que a seletividade é um fenômeno multifatorial, envolvendo aspectos biológicos, socioeconômicos e culturais — reforçando a necessidade de atualização contínua do nutricionista nesta área

O ICEBERG DA RECUSA ALIMENTAR

O que você vê é apenas 15% do problema.
O que está submerso define o tratamento.

≈ 15% VISÍVEL
(O SINTOMA)

A BASE SUBMERSA
(AS CAUSAS REAIS)



≈ 85% OCULTO
(A RAIZ DO PROBLEMA)



A PONTA VISÍVEL

O SINTOMA COMPORTAMENTAL

- Choro, birra e gritos à mesa
- Boca fechada e braços cruzados
- “Não quero!”, “Gosto ruim!”
- Seletividade aparente e rigidez com marcas e alimentos



O que os pais e a pediatria tradicional enxergam e tentam corrigir.

1



FISIOLOGIA OCULTA

Dor e desconforto.

Refluxo gastroesofágico não tratado, esofagite eosinofílica, constipação severa (fezes em esferas) ou alergias alimentares tardias.

2



DISFUNÇÃO SENSORIAL

O cérebro lê a textura como ameaça.

Hiper-reatividade tátil (pavor de alimentos úmidos/moles), hiperosmia (sensibilidade extrema a cheiros) ou hiporreatividade (busca apenas por crocantes para sentir o alimento).

3



IMATURIDADE MOTORA ORAL

A criança não consegue mastigar.

Hipotonia das bochechas, freio lingual alterado, respiração bucal crônica ou falta de tônus para quebrar a fibra da carne.

4



TRAUMAS NARRATIVOS

Memórias de sobrevivência.

Histórico de engasgo grave recente, episódios frequentes de vômito mecânico, internações com uso de sondas ou intubação.

5



DINÂMICA FAMILIAR COERCITIVA

O ambiente da mesa.

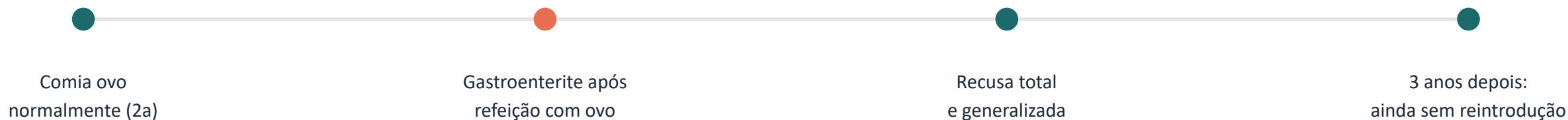
Ansiedade e angústia materna direcionadas ao prato, uso crônico de telas para distração, chantagens (“só ganha sobremesa se comer o brócolis”) ou alimentação forçada.

O QUE ESTÁ
SUBMERSO PRECISA
SER INVESTIGADO.

Ignorar essas camadas é tratar apenas o comportamento e não a causa que gera a recusa.

Por que ele não come mais ovo?

Condicionamento aversivo de sabor — Menino, 5 anos, sem ARFID



Mecanismo

One-trial learning / Efeito Garcia (Garcia & Koelling, 1966): o cérebro associa mal-estar gastrointestinal ao último alimento saliente ingerido — mesmo sem relação causal real. Formação em uma única exposição, alta resistência à extinção.



Por que “disfarçar” piorou

Pulou etapas da hierarquia de exposição (tolerar → interagir → cheirar → provar) e, ao ser percebido, quebrou a confiança — generalizando a vigilância para toda a refeição. A amígdala permanece em estado de alerta, sem habituação.

O que fica invisível na balança

 Fe FERRO • Anemia • Fadiga • Queda de imunidade • Déficit cognitivo	 Zn ZINCO • Baixo apetite • Imunidade reduzida • Alterações de paladar • Cicatrização prejudicada	 A VITAMINA A • Visão noturna • Imunidade • Crescimento • Integridade da pele e mucosas	 D VITAMINA D • Saúde óssea • Imunidade • Humor • Função muscular	 B12 VITAMINA B12 • Formação de células vermelhas • Função neurológica • Energia	 FIBRAS • Constipação • Disbiose intestinal • Inflamação • Menor saciedade
---	--	---	--	---	---

Espectro de gravidade



Sem impacto nutricional

Deficiências específicas

Falha de crescimento / enteral



Quando encaminhar para avaliação

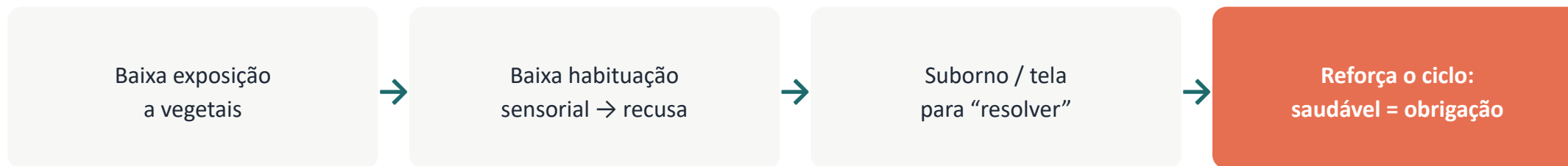
- ✓ Repertório alimentar < 20 alimentos
- ✓ Rigidez extrema (marca, embalagem, prato específico)
- ✓ Eliminação de um grupo alimentar inteiro
- ✓ Prejuízo social ou escolar
- ✓ Perda de peso / estagnação da curva de crescimento
- ✓ Histórico de sonda, refluxo grave ou trauma oral
- ✓ Engasgo, vômito ou pânico ao se alimentar



Presença de 1 ou mais sinais → encaminhar para avaliação multidisciplinar (nutricionista + fono + TO + psicólogo + pediatra).

Por que o suborno parou de funcionar?

Sistema de recompensa e sobrejustificação — Menina, 4 anos, peso em P85-P90



↻ o ciclo se retroalimenta

Efeito de sobrejustificação

Lepper, Greene & Nisbett (1973): reforço externo excessivo REDUZ a motivação intrínseca. Vincular o alimento a um prêmio ensina a criança que “esse alimento só vale a pena por causa do prêmio”.



Tela como reforçador competidor: além de prêmio, disputa atenção durante a refeição — prejudica a interocepção de fome/saciedade e a formação de memória alimentar positiva.

Seletividade alimentar: uma abordagem nutricional

Selective eating: a nutritional approach

Ana Beatriz de Mello Sampaio¹, Thais Lourenço Nogueira¹, Ruth Bartelli Grigolon¹, Ana Maria Roma¹,
Leticia Enrique Pereira¹, Karin Louise Lenz Dunker¹

A a literatura de estudos de caso é escassa mesmo internacionalmente — um artigo brasileiro publicado no *Jornal Brasileiro de Psiquiatria* discute justamente essa lacuna, citando que Timimi e colaboradores acompanharam por quatro anos 33 crianças seletivas, entre 4 e 14 anos, e apresenta um relato de caso próprio de uma paciente com seletividade alimentar que iniciou tratamento especializado aos 14 anos, com boa evolução clínica ligada à motivação pessoal e suporte familiar.

A divisão de responsabilidade na alimentação (sDOR)

Elly Satter para refeições saudáveis e mais leves.





Referências deste módulo

- Northstone, K., Emmett, P., Nethersole, F., & ALSPAC Study Team (2001). J Hum Nutr Diet, 14(1), 43-54.
- Cooke, L.J., Haworth, C.M.A., & Wardle, J. (2007). Am J Clin Nutr, 86(2), 428-433.
- Cardona Cano, S., Tiemeier, H., Van Hoeken, D. et al. (2015). Int J Eat Disord, 48(6), 570-579.
- Taylor, C.M., Wernimont, S.M., Northstone, K., & Emmett, P.M. (2015). Appetite, 95, 349-359.
- Zickgraf, H.F., & Bryant-Waugh, R. — tipologia dos subtipos de ARFID.
- Satter, E. — Modelo de Divisão de Responsabilidade na Alimentação.
- Garcia, J., & Koelling, R.A. (1966). Psychonomic Science, 4, 123-124.
- Lepper, M.R., Greene, D., & Nisbett, R.E. (1973). J Pers Soc Psychol, 28(1), 129-137.